Disciplina: PEDIATRIA II

Violência na infância

Prof. PATRICIA DAHAN

SUPREMA

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora

PLANO DE ENSINO

Curso: Semestre 2 de 2023 **Período:** 8º

Professor: PATRICIA DAHAN

Conteúdo Programático Abordado nesta aula:
Violência na infância

SUPREMA

- Por **MGTV Panorama**
- de Juiz de Fora **Em apenas um final de semana foram dois crimes**

- Fim de semana violento contra crianças em Juiz de Fora. A Polícia Civil investiga a publicação de fotos de um menino de nove anos, nu, na internet. E uma menina de dois anos teve o olho queimado com um cigarro.

- A menina teve uma queimadura no olho esquerdo. Ela passava o fim de semana com o pai. A mãe, que não vive mais com o companheiro, conta as duas versões que ouviu sobre o ferimento da filha. A primeira seria a de que o ferimento teria sido causado por um traficante de drogas em função da cobrança de uma dívida . A segunda, um acidente causado por um descuido do próprio pai enquanto bebia em um bar. O pai da criança foi detido e depois liberado. O suposto traficante ainda não foi encontrado.
- A Polícia Civil também investiga outra suspeita de crime contra crianças. No último sábado (26), a mãe de um menino de nove anos procurou o posto da Polícia Militar, no bairro Bandeirantes, na região Nordeste, com uma denúncia. As fotos dele nu teriam sido colocadas na internet pela prima de 18 anos e o namorado, de 26.
- As imagens teriam sido feitas num sítio e colocadas num site de relacionamento. O delegado Rodolfo Rolli não teve acesso às fotos porque ainda vai ouvir a mãe da criança e o casal. Se as denúncias forem comprovadas, a prima do menino e o namorado podem ser enquadrados em dois tipos de crime previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente: o de submeter a criança a vexame e publicar fotos, podendo haver ainda outros crimes, como molestamento.
- O caso da menina que teve queimadura no olho pode ser enquadrado como maus tratos, previsto no Código Penal. A pena varia de seis meses a um ano de prisão

SUPREMA

Uma das violências contra a criança e adolescente que também tem apresentado números alarmantes é a de caráter sexual, como abuso, exploração (com fins comerciais), aliciamento e pornografia envolvendo crianças, entre outras práticas. Segundo um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), metade dos casos de estupro de crianças e adolescentes tem como autor pais, padrastos, amigos ou conhecidos da vítima. O estudo, realizado a partir de dados coletados pelo Ministério da Saúde, revela ainda que 70% das vítimas de estupro em 2011 tinham menos de 18 anos. O número é mais grave quando se observa que metade das vítimas tinha até 13

JF tem mais de dez casos por mês de violência sexual contra menores

Denúncias foram levadas ao Conselho Tutelar nos últimos 16 meses; Promotoria acredita que estatísticas podem estar subnotificadas

COM ISOLAMENTO SOCIAL

Por **Marcos Araújo**
27/05/2021 às 10h00- Atualizada 27/05/2021 às 10h05

SUPREMA

Disque-100 registra 72 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes em 2022

Foram 22 mil denúncias a mais do que no primeiro semestre de 2021

17 denúncias por hora

Lideram estados SP,RJ e MG

SUPREMA

Injúria e Violência

- **O termo injúria se aplica a qualquer espécie de dano impingido a um indivíduo em que a ação praticada excede, em natureza e quantidade, seus limites de resistência.**

- **Injúria acidental : Acidente**
- **Injúria intencional : Violência**

SUPREMA

Introdução:

- A violência é, antes de tudo, uma violação dos direitos humanos, manifestando-se sob diversas formas, nos mais diferentes espaços e em todas as classes sociais (embora com diferenciações do seu conhecimento público), afetando a saúde e a qualidade de vida das pessoas.

SUPREMA

Estatuto da Criança e Adolescente

"Nenhuma criança ou adolescente sera objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma de lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais"

Artigos 7 a 14, 87,130 e 245 – maus tratos e penalidades

SUPREMA

Violência

Mais visível nas classes sócio econômicas mais desfavorecidas

MAUS TRATOS, ABUSOS, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mais sigilo nas classes sócio econômicas mais favorecidas

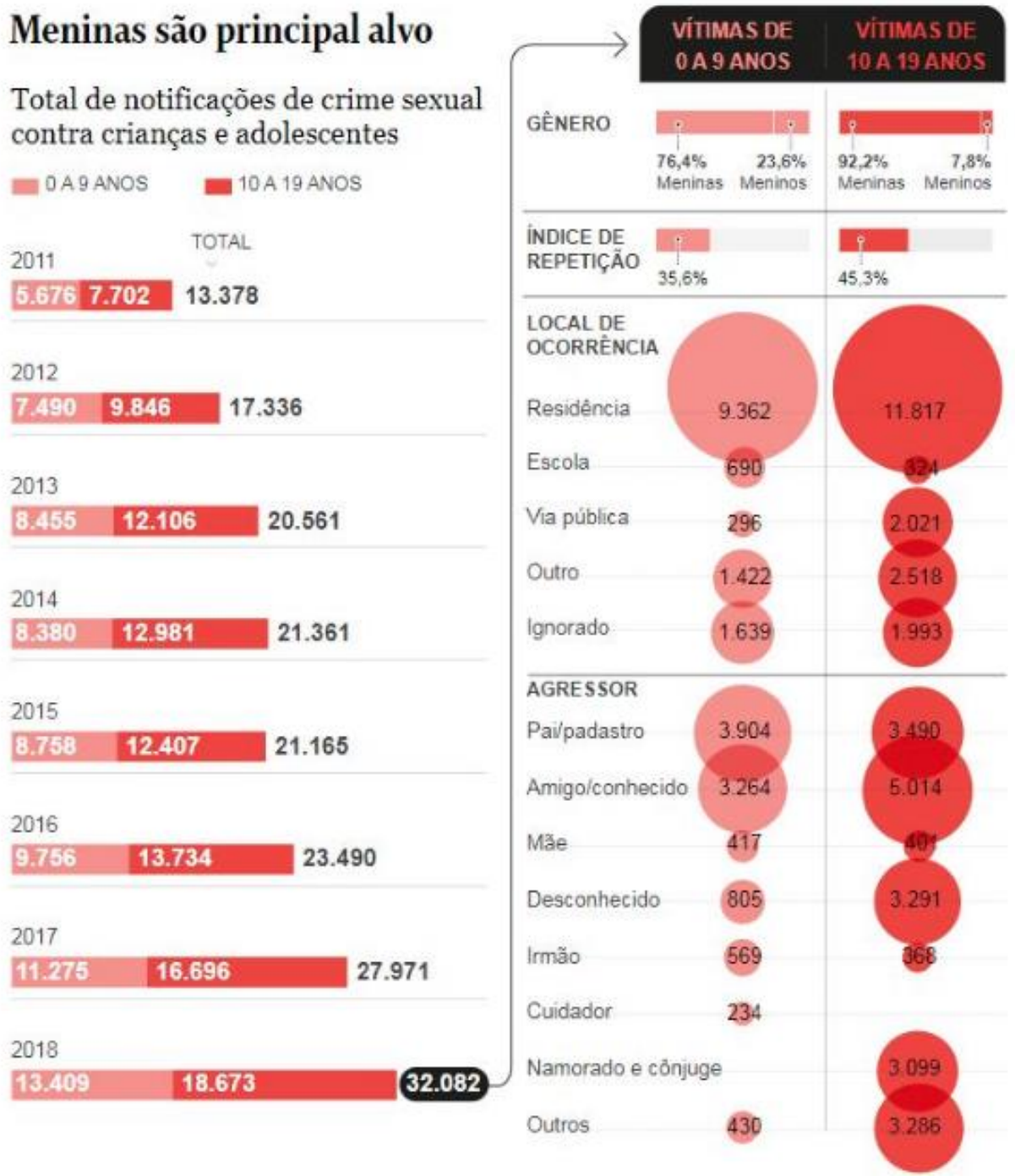
SUPREMA

- Maus-tratos sofridos na infância e adolescência

✓em sua maioria, no âmbito da casa e da família.

✓encobertos por um complô de silêncio, sob alegação de inviolabilidade do lar e não invasão.

SUPREMA



Dados Ministério da Saúde 2018

SUPREMA

- **10% das crianças que são atendidas em emergência devido a trauma são vítimas de maus-tratos; 5% delas morrerão nas mãos do agressor se não diagnosticadas e acompanhadas.**

SUPREMA



Cada criança que morre vítima de maus-tratos já passou por mais de 5 atendimentos em sala de emergência por esse motivo.

Juiz de Fora- Janeiro- Junho 2018

G1 ZONA DA MATA

Casos de estupro de menores correspondem a 87% das ocorrências em Juiz de Fora

Dados são do Protocolo de Atendimento ao Risco Biológico Ocupacional e Sexual.

Dados divulgados pelo Protocolo de Atendimento ao Risco Biológico Ocupacional e Sexual (Parbos) da Prefeitura de Juiz de Fora apontam que 87% das vítimas de estupro na cidade são menores de idade. O levantamento leva em consideração os casos registrados entre janeiro e junho deste ano.

Foram 85 casos registrados, sendo que em 74 deles as vítimas tinham menos de 18 anos. Em toda a região de Juiz de Fora, foram 108 casos nos seis primeiros meses de 2018. No ano passado, foram 230. Desses, 182 envolviam menores.

SUPREMA

Disque 100



Maus-tratos ou violência domestica

- Toda ação ou omissão praticada por adulto ou adolescente mais velho que, na qualidade de responsável, permanente ou temporário, tenha a intenção, consciente ou não, de provocar dor na criança ou adolescente, seja essa dor física ou emocional.

Guia de orientação para profissionais de saúde. Abrapia,1997

SUPREMA

Violência doméstica

- NÃO ACIDENTAL e sim INTENCIONAL
- Interpessoal, intrafamiliar
- Independe de classe social e nível cultural
- Ação ou omissão repetitiva
- Abuso do poder dos adultos e da força física
- Dano físico e/ou sexual e/ou psicológico
- Reversível ou irreversível

SUPREMA

Violência doméstica e violência sexual e psicológica

- Violência sexual : mais sexo feminino
- Agressores são frequentemente os próprios pais
- Maior risco de morte em crianças menores

- VIOLÊNCIA SEXUAL É SUBESTIMADA por ser menos visível
- VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA IMENSURÁVEL

SUPREMA

Importante:

- Situações de maior risco de maus-tratos:

✓Vínculos enfraquecidos ou ausentes entre filhos e pais

✓Criança "não desejada" ou não identificada como responsabilidade dos pais.

- Efeitos a curto e longo prazo

✓ Todo ato agressivo contra uma criança (mesmo que apenas verbal e de atitudes) que exceda sua capacidade de compreensão e elaboração produzirá efeitos que se manifestarão mais cedo ou mais tarde.

SUPREMA

Repercussões presente e futuro

- Lesão física reversível ou irreversível (seqüela/morte)
- Lesão sexual (DST/HIV)
- Distúrbio psicológico transitório/permanente
- Prostituição, drogadição, fuga de casa, suicídio, depressão, medos, obesidade, gravidez precoce, problemas escolares e relacionamento, infrações, pesadelos, isolamento ...

SUPREMA

Violência doméstica ou intrafamiliar.

- **NEGLIGÊNCIA**
- **ABUSO PSICOLÓGICO**
- **ABUSO FÍSICO**
- **ABUSO SEXUAL**

SUPREMA

Violência doméstica

- **NEGLIGÊNCIA**
  - **Caracteriza-se por OMISSÃO DE CUIDADOS BÁSICOS para crescimento e desenvolvimento, de forma intencional (consciente) ou não (social ou cultural), de forma crônica.**

- **ABANDONO : EXTREMA NEGLIGÊNCIA**

  Pode ser: físico, educacional ou emocional.

SUPREMA

Negligência



SUPREMA

Negligência



Negligência?



SUPREMA

Violência doméstica

- **ABUSO PSICOLÓGICO**: todas as formas de rejeição, isolamento, desrespeito, discriminação, depreciação, aterrorização, cobranças exageradas, humilhação, indução às drogas, crime ou prostituição. Utilização da criança ou adolescente com o objetivo de atender as necessidades dos adultos. Embutida nos outros tipos de maus-tratos e dificilmente evidenciada.

SUPREMA

Violência doméstica

- **ABUSO PSICOLÓGICO**:

  Pode resultar dos despreparo dos pais para educar seus filhos.

  Muito difícil de ser identificada,

  Quase sempre associada às demais formas de violência.

SUPREMA

Violência doméstica

- **ABUSO PSICOLÓGICO -Sinais mais comuns:**
  - agressividade, destrutividade
  - Apatia, isolamento, depressão
  - choro ou irritabilidade sem causa aparente,
  - medo ou ansiedade,
  - baixa auto-estima,
  - dificuldades de fala,
  - tiques ou manias,
  - enurese ou encoprese,
  - recusa alimentar em menores de 1 ano, distúrbios alimentares em maiores
  - uso de drogas, delinquência.

SUPREMA

Violência doméstica

- **ABUSO FÍSICO**: Uso da força física de forma intencional com produção de lesões corporais visíveis, com objetivo de manter ou demonstrar poder.



SUPREMA

CASTIGO X VIOLÊNCIA FÍSICA

FONTE UNICEF

- Em média, 6 em cada 10 crianças, de 2 a 14 anos de idade, no mundo, sofrem punições físicas regularmente pelas mãos de seus cuidadores. Na maioria dos casos, as crianças são submetidas a uma combinação de castigo físico e agressão psicológica.
- Apenas 3 em cada 10 adultos, no mundo, crêem que é preciso aplicar castigo físico para prover uma educação adequada. E, na maioria dos países, esta crença predomina entre adultos com um menor nível de escolaridade.

SUPREMA

Sobre o castigo….

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 13.010, DE 26 DE JUNHO DE 2014.

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, e altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

SUPREMA

Violência doméstica

- Lesões não compatíveis com idade ou desenvolvimento
- Lesões que não se justificam com relatos
- Lesões em várias partes do corpo
- Lesões em estágios diferentes de cura.
- Lesões em partes usualmente cobertas do corpo
- Inexplicável atraso entre o “acidente” e a procura de tratamento médico
- História e exame com sinais de múltiplos acidentes.

SUPREMA

Violência/ abuso físico

- Síndrome do bebê sacudido
- Síndrome da criança espancada
- Síndrome de Munchausen



SUPREMA

Síndrome do bebê sacudido

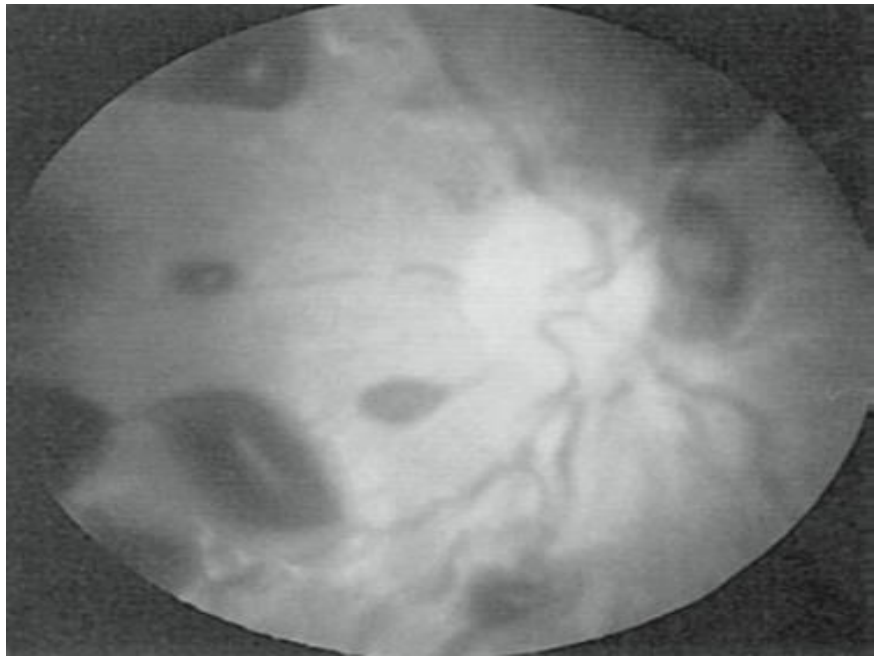


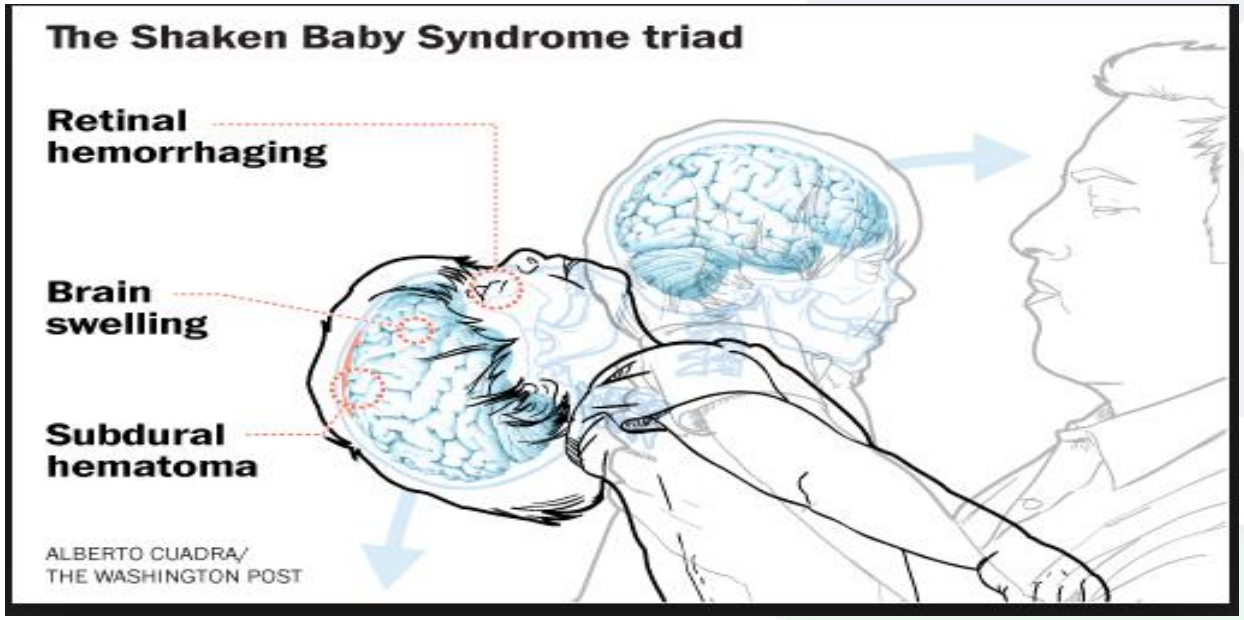
- Geralmente < 6 meses (até 2 anos)
- Lesão cerebral provocada por sacudidas violentas da criança.
- Produção de vários tipos de lesões vasculares e teciduais, por contusão, rompimento ou cisalhamento.

SUPREMA

Síndrome do bebê sacudido

Causa mais comum de TCE fechado grave em menores de 1 ano





SUSPEITAR QUANDO FALTAM ELEMENTOS QUE EXPLIQUEM A LESÃO EM UMA CRIANÇA GRAVE OU RARAMENTE QUANDO HOUVER CONFISSÃO

SUPREMA

Síndrome do bebê sacudido

- **HEMATOMA SUBDURAL + HEMORRAGIA RETINIANA + AUSÊNCIA DE TRAUMA CRANIANO** : tríade caracteriza a síndrome
- Também : Hemorragia subaracnóide; Infarto cerebral; Fraturas de arcos posteriores de costelas
- **COMA INEXPLICADO**: 50% óbito e 50% sobreviventes com seqüelas neurológicas

SUPREMA

Síndrome
da criança espancada

"Crianças de baixa idade que sofreram ferimentos inusitados, fraturas ósseas, queimaduras ocorridas em épocas diversas, bem como em diferentes étapas e sempre inadequada ou inconsistentemente explicada pelos pais"

(Azevedo & Guerra,1989)

Qualquer faixa etária mas
2/3 MENORES de 3 anos ;
1/3 MENORES de 6 meses
Grande número evolui para óbito
(trauma craniano e abdominal)

SUPREMA

Síndrome de *Munchausen*

por procuração

Adultos infligem doença em uma criança ou falsificam sintomas para obter atendimento médico para a criança

- Recorrência e persistência de quadro clínico.
- Múltiplas avaliações diagnósticas, exames e internações.
- Insatisfação com a conduta médica e insistência em realização de exames.

- Óbito inexplicado em um dos irmãos.
- Mãe "colaboradora e superenvolvida": descrições dramáticas
- Sinais surgem sempre em companhia da mesma pessoa.
- Sinais e sintomas que não respondem as terapias.

SUPREMA

Síndrome de *Munchausen*

por procuração

- A Síndrome se manifesta de três formas:

1. Mentira
2. Simulação
3. Indução

Diagnóstico é difícil e demorado,

Tempo médio de 3 a 6 meses.

SUPREMA

Violência doméstica

- **ABUSO SEXUAL**: todo ato ou jogo sexual cujo agressor está em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a criança ou adolescente.

  São práticas sexuais com ou sem contato, obrigadas através de indução de sua vontade, violência física ou ameaças

  Estudos internacionais mostram que aproximadamente 20% das mulheres e 5 a 10% dos homens relatam terem sido abusados sexualmente quando crianças.

SUPREMA

Violência doméstica

- **ABUSO ou VIOLÊNCIA SEXUAL**:

  Classificada em 2 formas:

1. Violência sexual intrafamiliar: pessoas com algum grau de parentesco ou que acreditem ter parentesco.

2. Exploração sexual comercial: coerção e violência, trabalho forçado, escravidão, uso de drogas.

SUPREMA

Abuso sexual: anamnese

- Em cerca de **80% dos casos, o abusador é um dos pais ou pessoa com algum laço afetivo com a família**
- As vítimas são, em geral, do sexo feminino e os abusadores do sexo masculino.
- Relato da vítima ou familiares (após identificação de DST).
- Denúncia de casais em separação litigiosa.

SUPREMA

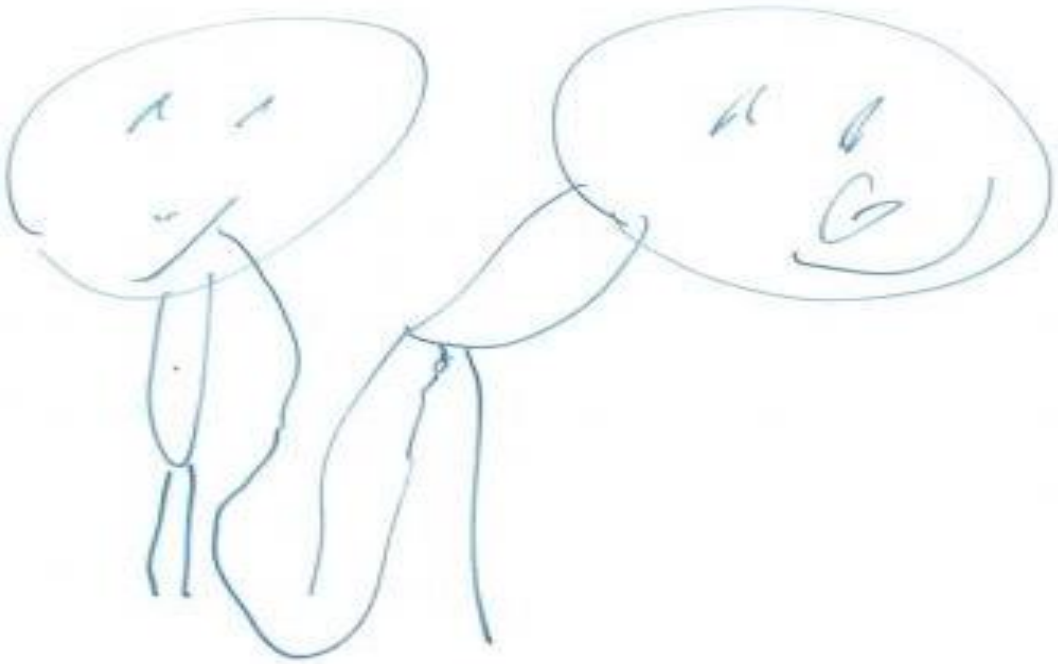
Abuso sexual:exame físico

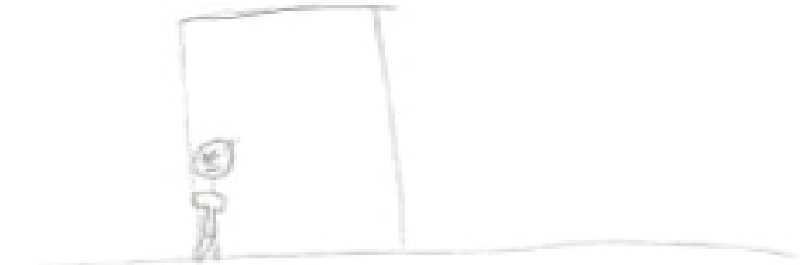
- Sinais de violência física: hematomas, mordidas (atenção especial para áreas usualmente envolvidas em atividades sexuais boca, mamas, genitais, região perineal, nádegas e ânus)
- Exame ginecológico: lesões de genitália, ânus, sinais de DST ou gestação.

MUITAS VEZES EXAME FÍSICO NORMAL

SUPREMA


Olly Picnic
Uncle
Daddy
Mummy
Me







SUPREMA

DESCONFIAR

Desconfiando de violência pela história

- **Discrepância nos fatos, cronologia dos eventos**
- **Retardo na busca de atendimento médico**
- **História incompatível com o grau de lesão**
- **Procura de vários hospitais e médicos diferentes**
- **Envenenamento**
- **Lesões em várias idades**

- **Acidentes em horários impróprios (madrugada)**
- **Pais indiferentes com a gravidade do ferimento; raramente tocam o filho**
- **Trauma incompatível com idade ou atividade**
- **Criança prefere rua ou escola à casa**
- **Mudança súbita humor e comportamento**

SUPREMA

Desconfiando de violência pela história

- Discordância nos relatos dos parentes com diferentes profissionais.
- Discordância nos relatos de vítimas e parentes.
- Discordância nos relatos de diferentes parentes.

- Problemas familiares com álcool e drogas.
- Desestruturação familiar
- Gravidez indesejada, tentativas frustradas de aborto, mães solteiras.
- História de abuso contra os próprios pais.

SUPREMA

Desconfiando de violência pelo exame físico



SUPREMA

Desconfiando de violência pelo exame físico

- **Contusão por cintos, fivelas, cordas, vergões, fio elétrico, escovas de cabelo, mordidas**
- **Contusão em olhos, boca, nariz, nádegas, palmas, plantas, genitália, tórax, músculos e membros, panturrilha**
- **Fratura inexplicada em criança que não anda**

- **Lesão fígado, baço ou coma súbito inexplicado**
- **Queimaduras circulares (cigarro) ou de imersão, com contorno (ferro), garfos ou facas**
- **Trauma genital ou DST**
- **Dano neurológico com hemorragia retiniana**
- **Má higiene**
- **Personalidade retraída ou explosiva**

SUPREMA

NÃO CONFUNDIR !!!

- Manchas mongólicas: não perdem a cor
- Hemofilia: distúrbios da coagulação
- Causas infecciosas/inflamatória
    - Eritema multiforme
    - Púrpura Henoch-Schönlein
    - Meningococcemia
- Tinturas em roupas: facilmente removidas com álcool

SUPREMA

Fenômeno da Violência Doméstica

- SILÊNCIO DO AGRESSOR E FAMILIARES
- SILÊNCIO DA VÍTIMA
- SILÊNCIO PROFISSIONAL

SUPREMA

Problemas na solução da violência

- **BAIXO ÍNDICE DE DENÚNCIAS**
  - vizinhos e ligações anônimas
- **SUBNOTIFICAÇÃO**
- **DESCONHECIMENTO**
- **FALTA COMPROMISSO**
  - população, autoridades, profissionais saúde e ensino

SUPREMA

Estatuto da Criança e do Adolescente - 1990

- ECA artigo 245
- **“ os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, com multa de 3 a 20 salários a não comunicação pelo médico ou responsável pelo estabelecimento de atenção à saúde ou ensino”**

SUPREMA

COMO AJUDAR ?

- **Atendimento médico**
- **Internação - equipe multidisciplinar**
- **Denúncia mediante simples suspeita**
- **Conselho Tutelar (tel: 3690-7352)**
- **Juizado da Infância e Juventude**
- **Disque Direitos Humanos = 0800 31 1119 ou DISQUE 100**

SUPREMA

Atendimento médico

- Ambiente acolhedor
- Respeitado e anotar o que está sendo relatado
- Não induzir o diagnóstico /Não minimizar a situação

- Avaliar os riscos reais para a criança

SUPREMA



0100

- informação emitida pelo Setor Saúde ou por qualquer outro órgão ou pessoa, para o Conselho Tutelar, com a finalidade de proteção da criança e do adolescente, vítimas de maus-tratos.
- inicia um processo que visa a interromper as atitudes e comportamentos violentos no âmbito da família e por parte de qualquer agressor
- **não é e nem vale como denúncia policial.**

SUPREMA

IMPORTANTE

- **NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE MAUS TRATOS É DEVER DO MÉDICO** (previsto no parágrafo único do artigo 28 do código de ética médica)

SUPREMA

SIGILO PROFISSIONAL?

- Prontuário : sigilo profissional

- **No entanto : em caso de risco a saúde física ou mental do menor de idade ou incapaz, o dever de notificar e informar as autoridades competentes sobre a violência é superior ao sigilo profissional**

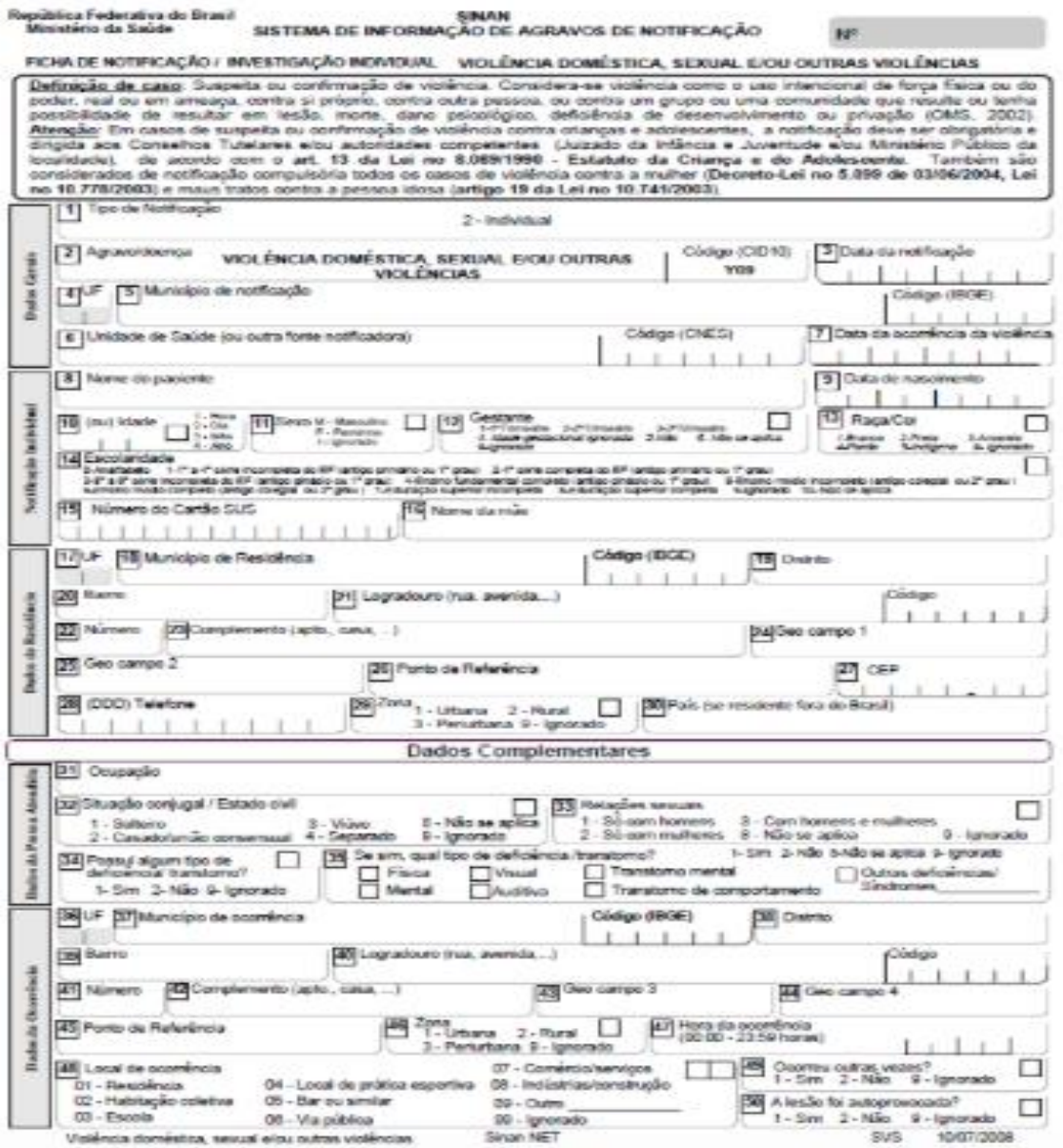
SUPREMA

Tratamento de vítimas de abuso sexual

- NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
- Atendimento em Juiz de Fora no HPS
- Acompanhamentos
    - Infectologia
    - Ginecologia
    - Psicologia
    - Social
    - Legal

SUPREMA

FICHA DE NOTIFICAÇÃO / INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS



República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

Nº

FICHA DE NOTIFICAÇÃO / INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS

Definição de caso: Suspeita ou confirmação de violência. Considera-se violência como o uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (OMS, 2002). **Atenção**: Em casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes, a notificação deve ser obrigatória e dirigida aos Conselhos Tutelares e/ou autoridades competentes (Juizado da Infância e Juventude e/ou Ministério Público da localidade), de acordo com o **art. 13 da Lei no 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente**. Também são considerados de notificação compulsória todos os casos de violência contra a mulher (**Decreto-Lei no 5.099 de 03/06/2004, Lei no 10.778/2003**) e maus tratos contra a pessoa idosa (**artigo 19 da Lei no 10.741/2003**).

Dados Gerais

1 Tipo de Notificação — 2 - Individual

2 Agravo/doença — VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS — Código (CID10): Y09 — 3 Data da notificação

4 UF — 5 Município de notificação — Código (IBGE)

6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora) — Código (CNES) — 7 Data da ocorrência da violência

Notificação Individual

8 Nome do paciente — 9 Data de nascimento

10 (ou) Idade — 1 - Hora; 2 - Dia; 3 - Mês; 4 - Ano

11 Sexo M - Masculino; F - Feminino; I - Ignorado

12 Gestante — 1-1º Trimestre; 2-2º Trimestre; 3-3º Trimestre; 4-Idade gestacional ignorada; 5-Não; 6-Não se aplica; 9-Ignorado

13 Raça/Cor — 1-Branca; 2-Preta; 3-Amarela; 4-Parda; 5-Indígena; 9-Ignorado

14 Escolaridade — 0-Analfabeto; 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau); 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau); 3-5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau); 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau); 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau); 6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau); 7-Educação superior incompleta; 8-Educação superior completa; 9-Ignorado; 10-Não se aplica

15 Número do Cartão SUS — 16 Nome da mãe

Dados de Residência

17 UF — 18 Município de Residência — Código (IBGE) — 19 Distrito

20 Bairro — 21 Logradouro (rua, avenida,...) — Código

22 Número — 23 Complemento (apto., casa, ...) — 24 Geo campo 1

25 Geo campo 2 — 26 Ponto de Referência — 27 CEP

28 (DDD) Telefone — 29 Zona: 1 - Urbana; 2 - Rural; 3 - Periurbana; 9 - Ignorado — 30 País (se residente fora do Brasil)

Dados Complementares

Dados da Pessoa Atendida

31 Ocupação

32 Situação conjugal / Estado civil — 1 - Solteiro; 2 - Casado/união consensual; 3 - Viúvo; 4 - Separado; 5 - Não se aplica; 9 - Ignorado

33 Relações sexuais — 1 - Só com homens; 2 - Só com mulheres; 3 - Com homens e mulheres; 8 - Não se aplica; 9 - Ignorado

34 Possui algum tipo de deficiência/ transtorno? — 1- Sim; 2- Não; 9- Ignorado

35 Se sim, qual tipo de deficiência/transtorno? — 1- Sim; 2- Não; 3-Não se aplica; 9- Ignorado — Física; Visual; Transtorno mental; Outras deficiências/ síndromes; Mental; Auditivo; Transtorno de comportamento

Dados da Ocorrência

36 UF — 37 Município de ocorrência — Código (IBGE) — 38 Distrito

39 Bairro — 40 Logradouro (rua, avenida,...) — Código

41 Número — 42 Complemento (apto., casa, ...) — 43 Geo campo 3 — 44 Geo campo 4

45 Ponto de Referência — 46 Zona: 1 - Urbana; 2 - Rural; 3 - Periurbana; 9 - Ignorado — 47 Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)

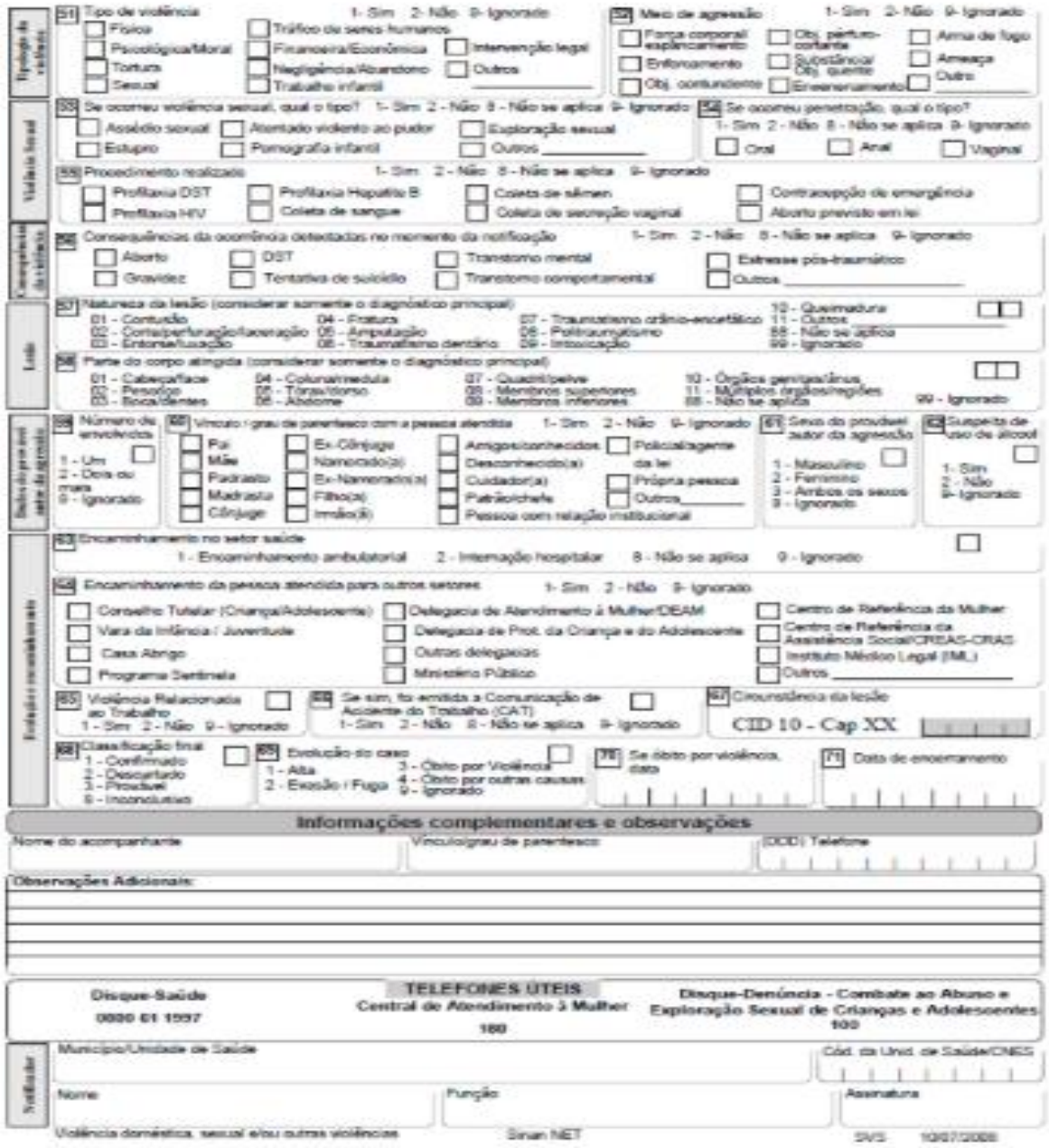
48 Local de ocorrência — 01 - Residência; 02 - Habitação coletiva; 03 - Escola; 04 - Local de prática esportiva; 05 - Bar ou similar; 06 - Via pública; 07 - Comércio/serviços; 08 - Indústrias/construção; 09 - Outro _____; 99 - Ignorado

49 Ocorreu outras vezes? 1 - Sim; 2 - Não; 9 - Ignorado

50 A lesão foi autoprovocada? 1 - Sim; 2 - Não; 9 - Ignorado

Violência doméstica, sexual e/ou outras violências — Sinan NET — SVS 10/07/2006

SUPREMA


Tipologia da violência
51 Tipo de violência 1- Sim 2- Não 9- Ignorado
Física
Psicológica/Moral
Tortura
Sexual
Tráfico de seres humanos
Financeira/Econômica
Negligência/Abandono
Trabalho infantil
Intervenção legal
Outros
54 Meio de agressão 1- Sim 2- Não 9- Ignorado
Força corporal/ espancamento
Enforcamento
Obj. contundente
Obj. perfuro-cortante
Substância/ Obj. quente
Envenenamento
Arma de fogo
Ameaça
Outros
Violência sexual
55 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1- Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9- Ignorado
Assédio sexual
Estupro
Atentado violento ao pudor
Pornografia infantil
Exploração sexual
Outros
56 Se ocorreu penetração, qual o tipo? 1- Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9- Ignorado
Oral
Anal
Vaginal
Procedimento realizado 1- Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9- Ignorado
Profilaxia DST
Profilaxia HIV
Profilaxia Hepatite B
Coleta de sangue
Coleta de sêmen
Coleta de secreção vaginal
Contracepção de emergência
Aborto previsto em lei
Consequências da violência
58 Consequências da ocorrência detectadas no momento da notificação 1- Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9- Ignorado
Aborto
Gravidez
DST
Tentativa de suicídio
Transtorno mental
Transtorno comportamental
Estresse pós-traumático
Outros
Lesão
57 Natureza da lesão (considerar somente o diagnóstico principal)
01 - Contusão
02 - Corte/perfuração/laceração
03 - Entorse/luxação
04 - Fratura
05 - Amputação
06 - Traumatismo dentário
07 - Traumatismo crânio-encefálico
08 - Politraumatismo
09 - Intoxicação
10 - Queimadura
11 - Outros
88 - Não se aplica
99 - Ignorado
58 Parte do corpo atingida (considerar somente o diagnóstico principal)
01 - Cabeça/face
02 - Pescoço
03 - Boca/dentes
04 - Coluna/medula
05 - Tórax/dorso
06 - Abdome
07 - Quadril/pelve
08 - Membros superiores
09 - Membros inferiores
10 - Órgãos genitais/ânus
11 - Múltiplos órgãos/regiões
88 - Não se aplica
99 - Ignorado
Dados do provável autor da agressão
59 Número de envolvidos
1 - Um
2 - Dois ou mais
9 - Ignorado
60 Vínculo / grau de parentesco com a pessoa atendida 1- Sim 2 - Não 9- Ignorado
Pai
Mãe
Padrasto
Madrasta
Cônjuge
Ex-Cônjuge
Namorado(a)
Ex-Namorado(a)
Filho(a)
Irmão(ã)
Amigos/conhecidos
Desconhecido(a)
Cuidador(a)
Patrão/chefe
Pessoa com relação institucional
Polícial/agente da lei
Própria pessoa
Outros
61 Sexo do provável autor da agressão
1 - Masculino
2 - Feminino
3 - Ambos os sexos
9 - Ignorado
62 Suspeita de uso de álcool
1- Sim
2 - Não
9- Ignorado
Encaminhamento
63 Encaminhamento no setor Saúde
1 - Encaminhamento ambulatorial 2 - Internação hospitalar 8 - Não se aplica 9 - Ignorado
64 Encaminhamento da pessoa atendida para outros setores 1- Sim 2 - Não 9- Ignorado
Conselho Tutelar (Criança/Adolescente)
Vara da Infância / Juventude
Casa Abrigo
Programa Sentinela
Delegacia de Atendimento à Mulher/DEAM
Delegacia de Prot. da Criança e do Adolescente
Outras delegacias
Ministério Público
Centro de Referência da Mulher
Centro de Referência da Assistência Social/CREAS-CRAS
Instituto Médico Legal (IML)
Outros
65 Violência Relacionada ao Trabalho 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
66 Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) 1- Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9- Ignorado
67 Circunstância da lesão
CID 10 - Cap XX
68 Classificação final
1 - Confirmado
2 - Descartado
3 - Provável
9 - Inconclusivo
69 Evolução do caso
1 - Alta
2 - Evasão / Fuga
3 - Óbito por Violência
4 - Óbito por outras causas
9 - Ignorado
70 Se óbito por violência, data
71 Data do encerramento
Informações complementares e observações
Nome do acompanhante
Vínculo/grau de parentesco
(DDD) Telefone
Observações Adicionais:
TELEFONES ÚTEIS
Disque-Saúde
0800 61 1997
Central de Atendimento à Mulher
180
Disque-Denúncia - Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
100
Notificador
Município/Unidade de Saúde
Cód. da Unid. de Saúde/CNES
Nome
Função
Assinatura
Violência doméstica, sexual e/ou outras violências
Sinan NET
SVS 10/07/2009

O Dano que fica:

- IMEDIATO ao trauma (estresse pós-traumático)
- A falta de maturidade psíquica e verbal e, muitas vezes, a ausência de apoio ou mesmo conivência familiar potencializam este sofrimento, dificultando o tratamento.
- Graus progressivos de dificuldades e déficits de desenvolvimento, atenção e aprendizado.

SUPREMA

SUSPEITE ACOLHA DENUNCIE



SUPREMA

Referências

- MARCONDES, E. et al. **Pediatria básica**. São Paulo: Sarvier; 2003.
- LOPES, F.A; DIOCLÉCIO,C.J; BURNS,D.A.R. **Tratado de Pediatria- Sociedade Brasileira de Pediatria.** São Paulo : Manole 3ª Ed. 2017.
- Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. *Notificação de maus-tratos contra crianças e adolescentes pelos profissionais de saúde: um passo a mais na cidadania em saúde.* Série A. Normas e Manuais Técnicos, n.167. Brasília – DF, 2002.
- Caderneta saúde escolar IBGE

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97870.pdf

- Pronap (Programa Nacional de Educação Continuada em Pediatria)

SUPREMA